·共识与指南·

新型冠状病毒感染门诊首诊患者的评估与管理指南(2023)

国家传染病医学中心　复旦大学循证医学中心
通信作者:张文宏,复旦大学附属华山医院感染科,上海　200040,Email:zhangwenhong@fudan.edu.cn;李太生,中国医学科学院　北京协和医学院　北京协和医院感染内科,北京　100730,Email:litsh@263.net

【摘要】 基于我国医疗机构门诊救治新型冠状病毒感染首诊患者的实际需求,《新型冠状病毒感染门诊首诊患者的评估与管理指南(2023)》提出了 9 个重要临床问题。在对国内外文献进行全面检索后,采用推荐等级的评估、制订与评价(GRADE)系统评估证据质量,推荐意见形成主要基于现有文献,如不能获得相关证据,则采用专家的观点及经验。经无利益冲突的专家组投票形成了具体的推荐意见和推荐强度,供临床医师诊治决策参考。

【关键词】 新型冠状病毒感染;门诊;诊断;治疗
DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20230616-00184　　中图分类号:R511

Guidelines for the assessment and management of first-visit adult outpatients with coronavirus disease 2019

National Medical Center for Infectious Diseases　Fudan University Center for Evidence-Based Medicine
Corresponding authors: Zhang Wenhong, Department of Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: zhangwenhong@fudan.edu.cn; Li Taisheng, Department of Infectious Diseases, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100730, China, Email: litsh@263.net

经过 3 年抗击新型冠状病毒感染(coronavirus disease 2019, COVID-19),特别是近期经历了一波新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2)大范围、高强度感染的冲击,已积累了大量基于我国病例的临床一线诊断与救治实战经验,部分经验虽然难以短时间内形成高质量循证医学证据,但这些经验与全球其他国家的证据和经验对我国各级医疗机构正确识别、评估和治疗未来的 COVID-19 起到至关重要的作用。鉴于此,国家传染病医学中心联合复旦大学循证医学中心,在《中华传染病杂志》和临床决策支持系统(UpToDate)的支持下,开展了 COVID-19 循证指引的编制工作。基于当前的最佳证据,结合我国一线诊治 COVID-19 的经验,制订了《新型冠状病毒感染门诊首诊患者的评估与管理指南(2023)》。

一、目标人群

前往门诊就诊的急性 COVID-19 成年患者。

二、应用人群

各级各类医疗机构门诊接诊 COVID-19 患者的医护人员。

三、方法学概述

(一)指南发起单位、工作流程

2022 年 4 月,由国家传染病医学中心、《中华传染病杂志》共同发起,联合全国各地感染性疾病等临床专家,编制了 COVID-19 系列指南。按照 WHO 指南手册的要求,规范了本指南的具体工作流程(图 1),本指南已在国际指南协作网(Guidelines International Network, GIN)注册。

(二)指南工作组

为保证指南对临床诊治实践的指导意义,并保证指南制作流程的规范性及研究方法的科学性,相关学科专家组成指南制订专家委员会。指南制订专家委员会由指南制作专家组和指南审阅专家组组成。指南制作专家组成员包括来自中国不同地区的 19 名临床专家、4 名临床流行病学专家、2 名生物统计学专家、3 名文献检索专家。专家委员会成员的利益冲突管理依据 WHO 和 GIN 对利益冲突管理的指导原则执行,小组成员向指南制作秘书组书面报告个人潜在利益冲突,利益冲突管理委员会负责判定利益冲突情况。指南审阅组专家分为内部专家和

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究

外部专家，内部审阅专家全程跟踪指南制作，外部审阅专家仅审阅成稿指南。为配合专家委员会工作，同时组建了指南制作学术秘书组和指南制作方法学团队。



注：PICO 为问题提出法

图 1　指南制订流程图

（三）证据检索

指南制作方法学团队针对每个数据库的特点，采取主题词和自由词相结合的方式分别检索了 PubMed、Embase、Web of Science、the Cochrane Library、中国生物医学文献数据库、中国知网、维普网、万方数据知识服务平台等数据库。此外，在英国国家卫生和临床技术优化研究所（National Institute for Health and Care Excellence，NICE）、GIN、苏格兰校际指南网络（Scottish Intercollegiate Guidelines Network，SIGN）、美国卫生健康研究所与质量机构（Agency for Healthcare Research and Quality，AHRQ）/美国国立实践技术指南库（National Guideline Clearinghouse，NGC）、Guideline Central 等指南数据库查找相关指南，翻阅其参考文献目录作为补充检索。初步检索完成于 2022 年 3 月，针对临床问题的检索时间为 2022 年 7 月。因证据更新速度较快，2023 年 1 月将临床问题拆分为多个指南分别完成。检索到的所有文献导出后应用 EndNote 文献管理软件进行数据去重。双人独立筛选去重后的文献，并追溯纳入研究的参考文献。采用统一的提取表格，独立完成文献的数据提取，并通过讨论或咨询第 3 位研究人员的方式解决分歧。借助 UpToDate 交叉验证双方证据的完整性，并于 2023 年 2 月对文献又进行了补充检索，同年 6 月再次对个别问题的证据进行了补充检索。

（四）推荐意见形成

学术秘书组通过多轮德尔菲法征询专家对相关临床问题的意见，和方法学团队一起结合现有证据情况列出 9 个临床问题：

1. 已确诊 COVID-19 成年患者应在门诊接受哪些初始评估？

2. 在实行分级诊疗的地区，各级诊疗机构如何分工合作救治？

3. 哪些患者进行 COVID-19 抗病毒治疗？

4. 如何选择 COVID-19 抗病毒治疗的药物？

5. COVID-19 门诊患者糖皮质激素治疗的适应证。

6. 是否需要对 COVID-19 门诊患者使用抗凝/抗血小板治疗？

7. 是否需要对 COVID-19 门诊患者使用抗菌药物治疗？

8. 对于 COVID-19 门诊患者应如何实施退热治疗？

9. 门诊患者中医中药使用时机及人群。

本指南采用推荐等级的评估、制订与评价（grading of recommendations assessment, development, and evaluation，GRADE）系统评估证据质量，并利用证据到决策框架（evidence to decision framework，EtD）形成推荐意见，从而最大限度减小偏倚，提高指南制作的科学性。通过 GRADE 系统评估证据体质量，将证据级别分为高质量、中等质量、低质量和极低质量。本指南的推荐强度分为强、弱和良好实践声明（good practice statement，GPS）[1-2]。决定专家组推荐强度的因素包括证据体质量、利弊平衡与负担、意愿和价值观、资源利用等[3]。

本指南主要基于现有文献，如不能获得相关证据，则采用专家的观点及经验。本指南评估了 2023 年 2 月之前出版的文献及相关资料，并在 6 月对个别问题的文献及相关资料再次进行评估，并根据 GRADE 系统评估推荐意见（表 1）。推荐意见的强度分为 3 个等级：强（1）、弱（2），对于无证据支持的临床问题，则依据专家临床经验，形成基于专家共识的推荐意见（GPS）。方法学团队提前将存在证据的每个问题的证据级别分为 4 个水平：高（A）、中（B）、低（C）、极低（D）。证据质量越高，就越能保证推荐意见的强度越强；价值及偏好的可变性越强，或

者不确定性越大，则越可能为弱推荐意见。推荐意见增加了推荐说明，以便推荐意见的实施。推荐意见尽可能依据最可靠的临床研究的证据，缺乏高级别证据时参考当前可得到的最佳证据，并充分讨论达成共识。其中 5 个关键问题的证据资料整理在该指南对应推荐意见的证据概述部分。剩下几个问题只有少数及非直接证据，其相关研究归纳在每条推荐意见后。

表 1　推荐意见的证据级别和推荐强度

级别	详细说明	标识
证据级别		
高质量	进一步研究基本不可能改变对该评估结果的信心	A
中等质量	进一步研究有可能对该评估结果的信心产生重要影响，且该评估结果可能改变	B
低质量	进一步研究很有可能影响该评估结果，且该评估结果很有可能改变	C
极低质量	任何评估结果都非常不确定	D
总体推荐强度		
强推荐	充分考虑到证据的质量，患者可能的预防、诊断和治疗成本而最终得出的推荐意见	1
弱推荐	证据价值参差不齐，推荐意见存在不确定性，或推荐的意见可能会有较差的成本疗效比，更倾向于较低等级的推荐	2
GPS	依据专家临床经验形成基于专家共识的推荐意见	GPS

注：GPS 为良好实践声明

四、推荐意见及说明

推荐意见和推荐强度基于国家现有政策规范，以及已获取的国内外相关证据。在临床上可根据患者的实际情况进行个体化处理。

问题 1：已确诊 COVID-19 成年患者应在门诊接受哪些初始评估？

推荐意见 1：建议已确诊 COVID-19 成年患者在门诊接受如下初始评估，以确定是进一步就诊或转诊。① 疾病症状及严重程度；② 氧饱和度；③ 具有进展为重症的高危因素；④ 病程。（证据级别为专家意见；推荐强度为 GPS）

推荐说明：已经经过病原学和（或）血清学检查确诊 COVID-19 的患者应在门诊接受初始评估，初始评估内容包括：① 根据症状评估疾病的严重程度，是否出现咳嗽、持续发热，气促、胸痛/压迫感、神志改变（如嗜睡、意识模糊、行为改变、难以唤醒等）、发绀等，以此评估患者病情的总体严重程度；② 气促还可能与缺氧有关，因此应监测患者在静息不吸氧状态下的氧饱和度，并结合整体临床表现判断患者呼吸系统症状是否有临床意义；③ 对于存在进展至重症高危因素（表 2）的患者需格外重视；④ 获取详细病史，明确患者就诊时的病程，以确定目前可用的抗病毒治疗方案。

问题 2：在实行分级诊疗的地区，各级诊疗机构如何分工合作救治？

表 2　重型/危重型新型冠状病毒感染的高危因素[4-5]

序号	具体高危条件
1.	年龄≥65 岁，尤其是未全程接种新型冠状病毒疫苗者
2.	有心脑血管疾病（含高血压）、慢性肺部疾病（如间质性肺病、肺栓塞、肺动脉高压、支气管扩张症、慢性阻塞性肺病等）、糖尿病、慢性肝脏疾病（如肝硬化、非酒精性脂肪性肝病、酒精性肝病、自身免疫性肝炎等）、肾脏疾病、肿瘤等基础疾病以及维持性透析患者
3.	免疫功能缺陷（如艾滋病患者、长期使用皮质类固醇或其他免疫抑制药物导致免疫功能减退状态）
4.	肥胖（体质指数≥30）
5.	晚期妊娠和围产期女性
6.	重度吸烟者

推荐意见 2：在具备分级诊疗条件的地区，推荐如下分级诊疗方案。① 各级医疗机构门、急诊医师评估分型；② 一级医疗机构可以提供轻型及部分中型患者的临床诊疗；③ 二级医院提供轻型、中型和部分重型病例救治；④ 三级医院负责重型和危重型病例救治。（证据级别为专家意见；推荐强度为 GPS）

推荐说明：各级医院门、急诊医师通过初始评估对感染者进行临床分型，并评估是否进一步就诊。如具备分级诊疗条件，推荐按照疾病严重程度及治疗难易程度进行分级诊疗。一级医院负责轻型及部分中型感染者的诊治，如有严重基础疾病，或基础疾病明显加重者，可转诊至上一级医院。二级医院可收治轻型、中型及部分重型患者，由三级医院负责所在辖区重型和危重型病例的救治，并加强对二级医院的技术指导。血液透析、肿瘤放射化学治疗患者由原就诊医院优先救治（图 2）。

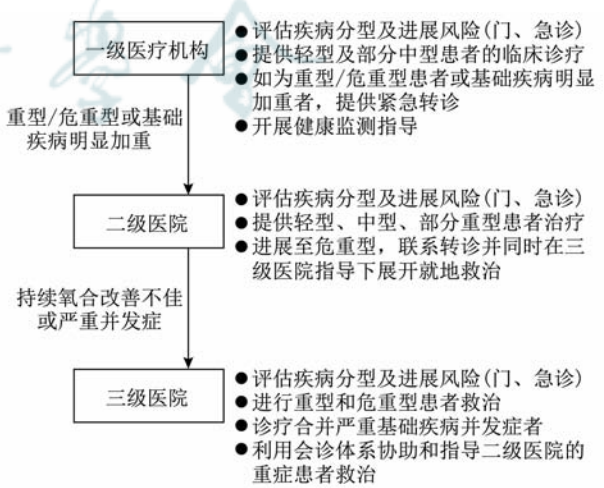


图 2　具备分级诊疗条件的地区推荐分级诊疗方案

问题 3：哪些患者进行 COVID-19 抗病毒治疗？

推荐意见 3：推荐轻型、中型和部分重型 COVID-19 患者抗病毒治疗。（证据级别为专家意见；推荐强度为 GPS）

推荐说明：建议对下述门诊患者进行 COVID-19 抗病毒治疗。

1. 对于有 COVID-19 相关症状的轻型、中型，且伴有进展至重症高危因素的患者，均应尽早给予 COVID-19 抗病毒治疗。

2. 对于重型 COVID-19 患者，如 SARS-CoV-2 病原学检测仍阳性，建议给予 COVID-19 抗病毒治疗并及早收治。

问题 4：如何选择 COVID-19 抗病毒治疗的药物？

推荐意见 4：抗病毒治疗药物的选择，建议优先选用口服小分子药物。药物选择需根据患者的基础疾病、合并用药，以及对药物的耐受情况做出个体化的药物推荐，明确患者是否有相关药物的禁忌证。（证据级别为中等质量；推荐强度为强推荐）

证据概述：

1. 奈玛特韦片/利托那韦片包装组合：两项双盲、随机、对照、Ⅱ/Ⅲ期试验（EPIC-HR 及 EPIC-SR）结果均显示奈玛特韦/利托那韦可减少轻型、中型 COVID-19 门诊成年患者的住院率：① EPIC-HR 试验纳入 2 246 例未接种疫苗且有进展至重症风险的患者，与安慰剂组（1 126 例）相比，症状发作 3 d 内给予奈玛特韦/利托那韦（1 120 例）可使 28 d 住院或死亡相对风险降低 88.9%（$P<0.001$），两组的不良事件（adverse event）发生率相似（22.6% 比 23.9%）[6]。② EPIC-SR 试验纳入 991 例未接种疫苗，和至少有 1 个进展至重症风险且已接种疫苗的患者，奈玛特韦/利托那韦也显示出可降低住院风险的效果，但由于住院率和病死率过低，该研究提前终止[7]。

一项针对 BA.2 和 BA.5 型变异株流行期间非住院患者的真实世界队列研究结果显示，奈玛特韦/利托那韦组（9 881 例）较对照组（11 612 例，即不治疗）的 28 d 全因住院率（$OR=0.45$，95%CI 0.33～0.62）和全因死亡率（$OR=0.15$，95%CI 0.03～0.50）显著降低[8]。

2. 阿兹夫定片：在巴西开展了两项分别针对轻型（281 例）和中型（172 例）COVID-19 成年患者的多中心、随机双盲、安慰剂对照、Ⅲ期试验，结果均显示与安慰剂组相比，阿兹夫定组核酸首次转阴的时间明显缩短（轻型为 5.55 d 比 8.27 d，$P<0.001$；中型为 6.24 d 比 7.94 d，$P=0.002$），用药后第 3 天开始病毒载量显著降低[9-10]。

3. 莫诺拉韦胶囊：莫诺拉韦的临床证据表现不一致：① 一项多中心、开放标签、随机对照试验（PANORAMIC），纳入 26 411 例年龄≥50 岁或≥18 岁且有相关合并症、在 5 d 内确诊轻型 COVID-19 患者，与标准治疗组相比，莫诺拉韦并未降低高危人群的住院率或病死率（1% 比 1%，校正 $OR=1.26$，95%CI 0.81～1.41）[11]。② 一项双盲、随机、安慰剂对照、Ⅲ期试验（MOVe-OUT），纳入 1 433 例在 5 d 内确诊为轻、中型 COVID-19，未接种疫苗且有至少 1 个进展至重症危险因素的非住院患者，莫诺拉韦较安慰剂可显著降低 29 d 内住院或死亡风险（6.8% 比 9.7%，-3%，95%CI -5.9～-0.1）[12]。③ BA.2.2 型变异株流行期间的一项观察性研究入组了 1 074 856 例 COVID-19 非住院患者，早期给予莫诺拉韦的患者较不接受莫诺拉韦治疗患者的死亡风险更低（$HR=0.76$，95%CI 0.61～0.95），但两组住院风险相似（$HR=0.98$，95%CI 0.89～1.06）[13]。④ 一项在日本进行的真实世界、回顾性队列研究，使用 1∶3 倾向性评分匹配后，共纳入 230 例患者接受莫诺拉韦治疗，690 例患者未接受莫诺拉韦治疗，结果显示与未接受莫诺拉韦的对照组相比，莫诺拉韦组疾病恶化风险（需要额外药物治疗的呼吸疾病恶化，或住院第 1 天后需要呼吸治疗）显著降低（8.4% 比 3.9%，$P=0.034$），且多变量分析显示接受莫诺拉韦治疗不受其他协变量影响，是预防住院后病情恶化的风险因素（$OR=0.448$，95%CI 0.206～0.973，$P=0.042$）[14]。

4. 氢溴酸氘瑞米德韦片（VV116）：一项在上海市 7 家 COVID-19 定点医院开展的单盲、随机、对照、Ⅲ期临床试验（NCT05341609）中，纳入 771 例伴有高进展风险的轻、中型 COVID-19 成年患者，氢溴酸氘瑞米德韦片的持续临床恢复时间非劣于奈玛特韦/利托那韦（$HR=1.17$，95%CI 1.02～1.36）[15]。氢溴酸氘瑞米德韦片的不良事件发生率低于奈玛特韦/利托那韦（全部不良事件为 67.4% 比 77.3%，3 或 4 级不良事件为 2.6% 比 5.7%）。

5. 先诺特韦片/利托那韦片组合包装：一项未发表的研究纳入 1 208 例有症状、年龄≥18 岁、首次感染≤5 d 且症状发作≤3 d 的轻、中型 COVID-19 患者，在首次达到症状持续恢复时间方面，先诺特韦片/利托那韦片相较安慰剂缩短约 1.5 d，中重症高风险亚组人群缩短约 2.4 d；在病毒载量方面，用药后第 5 天，先诺特韦片/利托那韦片组病毒载量对比安慰剂组最大下降超 96%，且核酸转阴时间较安慰剂组缩短约 2.2 d[16]。

6. 来瑞特韦片：在轻、中型 COVID-19 患者中开展的一项随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究（RAY1216-22-02），纳入 1 359 例 18～75 岁、随机前

120 h 内检测 COVID-19 阳性、随机前 48 h 内首次出现且随机前尚存在至少 1 种 COVID-19 症状/体征的患者，并以 1∶1 接受来瑞特韦片 400 mg/次或安慰剂，3 次/d，共服药 5 d；结果显示来瑞特韦组较安慰剂组显著缩短 11 种症状至持续临床恢复时间；给药第 4 天，来瑞特韦组较安慰剂组病毒载量显著下降，达 0.82 lg 拷贝/mL（$P<0.001$）；与安慰剂组相比，来瑞特韦组在不同时间点的 11 种症状至持续临床恢复的受试者比例、病毒转阴时间及不同时间点病毒转阴的受试者比例等方面也显示出一致的疗效；来瑞特韦组不良事件发生率与安慰剂组相当，两组均无 COVID-19 相关疾病进展为住院或死亡的事件发生；此外，在基线病毒载量较高（>8 lg 拷贝/mL）的亚组患者中，试验组和安慰剂组至持续临床恢复中位时间分别为 262.22 h 和 313.55 h[17-18]。

推荐说明：① 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装和莫诺拉韦胶囊均用于发病 5 d 内的轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成年患者[4]，但两款药物治疗后均会发生 COVID-19“反弹”[19-20]，即在停止治疗后 5～8 d 内发生，尚不确定其发生机制，因此在抗病毒治疗完成后应持续监测[20-21]。此外，动物研究显示，孕妇服用莫诺拉韦可能会对胎儿造成伤害，不建议妊娠期妇女进行莫诺拉韦治疗[22]。② 建议选择单克隆抗体时必须考虑 SARS-CoV-2 变异株对单克隆抗体的敏感性（表 3）。③《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》推荐 COVID-19 人免疫球蛋白和康复者恢复期血浆在病程早期用于有重症高风险因素、病毒载量较高、病情进展较快的患者[4]。④ 氢溴酸氘瑞米德韦片、先诺特韦片/利托那韦片组合包装和来瑞特韦片均属国家药品监督管理局附条件批准上市，用于治疗轻、中型 COVID-19 的成年患者，建议严格按说明书对患者用药[23-24]。

表 3　单克隆抗体对新型冠状病毒变异株（奥密克戎亚型）的敏感性[25-29]

奥密克戎亚型变异株	单克隆抗体	
	替沙格韦单抗-西加韦单抗	安巴韦单抗-罗米司韦单抗
BA.1	活性降低	活性降低
BA.2	有活性	有活性
BA.4/BA.5	活性降低	有活性
BA.4.6（BA.4）	无活性	-
BA.2.75.2（BA.2）	无活性[a]	-
BQ.1/BQ.1.1（BA.5）	无活性	-
XBB/XBB.1/XBB.1.5（BA.2.10.1 和 BA.2.75 重组）	无活性	-

注：[a]对于相关的亚谱系 BA.2.75，替沙格韦单抗-西加韦单抗似乎保留了中和活性。

问题 5：COVID-19 门诊患者糖皮质激素治疗的适应证

推荐意见 5.1：对无吸氧需求的轻型及中型 COVID-19 患者，不推荐全身使用糖皮质激素治疗。需要说明的是，如果上述患者疾病出现进展（包括新出现吸氧需求或需要更高级别的呼吸支持），推荐在评估全身使用糖皮质激素风险和获益后，酌情考虑短期使用糖皮质激素。（证据级别为中等质量；推荐强度为强推荐）

证据概述：一项英国开放标签、多中心（176 个）、随机、对照试验（RECOVERY），将 6 425 例住院患者随机分配到地塞米松组（6 mg/次，1 次/d，持续 10 d）和标准治疗组；地塞米松组随机后 28 d 死亡风险显著降低（*RR* = 0.85，95%*CI* 0.75～0.93），预先设定亚组也表现类似结果：仅氧疗组 *RR* 为 0.82（95%*CI* 0.72～0.94），有创机械通气组 *RR* 为 0.64（95%*CI* 0.51～0.81）[30]。

推荐说明：作为全球大型针对治疗 COVID-19 随机对照试验（randomized controlled trial，RCT）之一的 RECOVERY 试验发现，无吸氧需求患者接受地塞米松治疗不能改善临床结局，但对有吸氧需求的患者却有益。因此，建议对于疾病出现进展（即新出现吸氧需求或需要更高级别呼吸支持）的 COVID-19 门诊患者，如有基础疾病与高龄等高危因素，评估无激素使用禁忌后，宜在病情出现进展的初期提早应用低剂量糖皮质激素，地塞米松（0.75 mg/片）或者泼尼松（5 mg/片）每日 4～6 片治疗。若治疗 72 h 后疾病仍然出现进展，不吸氧难以维持正常的氧饱和度，则需要转诊至上级医院进一步治疗。治疗 72 h 后病情显著缓解者，可减量至每天 2～3 片，再治疗 3～5 d。

推荐意见 5.2：由于有关吸入性糖皮质激素疗效的证据不一致，同意美国感染病学会（Infectious Diseases Society of America，IDSA）的意见，不推荐使用吸入性糖皮质激素治疗 COVID-19，除非开展相关临床试验。（证据级别为中等质量；推荐强度为强推荐）

证据概述：

1. 纳入 3 项 RCT 文献的 Cochrane 系统评价（3 项 RCT 均纳入未接种疫苗的轻型 COVID-19 患者，比较吸入性糖皮质激素加标准治疗和标准治疗加/不加安慰剂的有效性和安全性）结果显示，在 30 d 随访周期内，吸入性糖皮质激素组较标准治疗组的全因死亡风险（*RR* = 0.61，95%*CI* 0.22～1.67；2 132 例，低质量证据）、住院或死亡复合风险（*RR* = 0.72，95%*CI* 0.51～1.30；2 025 例，中等质量证据）和不良事件发生风险（*RR* = 0.78，95%*CI* 0.47～1.31；

400 例，低质量证据），均无显著差异[31]。

2. 一项英国多中心、开放标签、多臂、前瞻性、随机、对照、适应性平台试验（PRINCIPLE）纳入年龄≥65 岁或≥50 岁且有合并症的 COVID-19 门诊患者，其中 787 例随机分配至布地奈德组（800 μg/次、2 次/d，连续 14 d），1 069 例随机分配至标准治疗组；布地奈德组较标准治疗组的 28 d 住院或病死率降低，但差异无统计学意义[6.8% 比 8.8%，*OR* = 0.75，95% 贝叶斯可信区间（95% Bayesian credible interval，95% *BCI*）0.55 ~ 1.03][32]。

3. 一项美国多中心（10 个）、双盲、随机、对照、Ⅲ期临床试验纳入 400 例有症状、年龄≥12 岁的青少年和成年 COVID-19 非住院患者，随机分配至环索奈德组（197 例，320 μg/次、2 次/d、持续 30 d）和安慰剂组（203 例）。两组 30 d 全部症状恢复情况差异无统计学意义（*OR* = 1.28，95%*CI* 0.84 ~ 1.97），30 d 住院或死亡方面差异也无统计学意义（1.5% 比 3.4%，*OR* = 0.45，95%*CI* 0.11 ~ 1.84），且均无死亡事件；但与安慰剂组相比，环索奈德组减少了复合结局（30 d 内急诊科就诊或住院）的发生率（1% 比 5.4%，*OR* = 0.18，95%*CI* 0.04 ~ 0.85，*P* = 0.03）[33]。

推荐说明：考虑到没有证据能一致表明，吸入性糖皮质激素对非重症 COVID-19 门诊患者有效，且大多数结果的证据质量为中等或低。因此，不推荐使用吸入性糖皮质激素治疗 COVID-19 患者。

问题 6：是否需要对 COVID-19 门诊患者使用抗凝/抗血小板治疗？

推荐意见 6.1：对于未开始使用此类药物的患者，则不推荐在门诊开始抗凝或抗血小板药物治疗，除非有特定的治疗指征。（证据级别为中等质量；推荐强度为强推荐）

证据概述：

1. 一项开放标签、多中心（6 个国家 15 个中心）、随机、对照、Ⅲb 期试验（ETHIC）纳入了年龄至少为 30 岁、未接种 SARS-CoV-2 疫苗、门诊确诊为 COVID-19 且有症状、至少有 1 个严重疾病风险因素的 219 例受试者，其中 105 例随机分配到试验组（皮下注射依诺肝素 21 d），114 例随机分配到标准治疗组（无依诺肝素）；该研究因入组率和事件率低于预期而早期停止，两组 21 d 全因死亡或住院的复合终点发生率均为 11%，差异无统计学意义（*P* = 0.83）；在 21 d 的随访周期内，试验组和标准治疗组出血事件的发生率分别为 2% 和 1%，不良事件发生率分别为 21% 和 11%，试验组 1 例受试者死亡，但死因不明[34]。

2. 在瑞士和德国 8 个中心进行的一项随机、开放标签、平行Ⅲ期试验（OVID）将 50 岁及以上、具有呼吸道症状或体温高于 37.5 ℃ 的急性 COVID-19 门诊患者以 1∶1 的比例随机分配到试验组（皮下注射依诺肝素 40 mg/次，1 次/d，为期 14 d）和标准治疗组（无血栓预防措施）；该研究在中期分析时由于无法达到预期有效性标准而早期终止；试验组 30 d 全因死亡或住院的复合主要评价指标，发生率（8/234）和标准治疗组发生率（8/238）均为 3%，差异无统计学意义（校正后 *P* = 0.96）；研究期间无死亡和大出血事件发生，试验组和标准治疗组的严重不良事件分别发生 9 例和 8 例[35]。

推荐说明：目前尚无证据表明抗凝药物或抗血小板药物可以降低住院或死亡风险，因此不推荐 COVID-19 患者进行抗凝或抗血小板治疗，如患者有特定治疗指征必须进行抗凝，需请如心内科、血液科、血管外科等相应专科医师进行会诊。

推荐意见 6.2：对于已使用抗凝药物或抗血小板药物治疗基础病的 COVID-19 门诊患者，推荐继续使用此类药物。（证据级别为专家意见；推荐强度为 GPS）

推荐说明：该推荐意见无直接证据，美国国立卫生研究院（National Institutes of Health，NIH）2022 年版 COVID-19 治疗指南基于专家共识推荐了该项意见，且为强推荐[36]。本指南同意同意 NIH 的意见，推荐对已开始抗凝或抗血小板治疗基础病的 COVID-19 门诊患者使用此药物。

问题 7：是否需要对 COVID-19 门诊患者使用抗菌药物治疗？

推荐意见 7：COVID-19 门诊患者无需抗菌药物治疗，除非合并细菌感染。（证据级别为中等质量；推荐强度为强推荐）

证据概述：

1. 2020 年一项基于英国初级保健、开放标签、适应性平台设计的随机对照临床试验（PRINCIPLE）中，纳入年龄≥65 岁或≥50 岁且至少有 1 种基础疾病、疑似 COVID-19 的社区受试者，其中 540 例被随机分配到阿奇霉素加常规护理组（联用组），875 例随机分配到常规护理组（常规组）；80% 联用组的受试者和 77% 常规组受试者在 28 d 内感觉恢复，同时联用组的首次报告恢复时间与常规组相比，差异并无统计学意义的获益（*HR* = 1.08，95%*CI* 0.95 ~ 1.23）；两组转住院的比例均为 3%，且均无死亡病例[37]。

2. 2020 年 5 月至 2021 年 3 月在美国进行的一项随机对照临床试验纳入了 263 例 SARS-CoV-2 阳

性的成年门诊患者，结果显示与安慰剂相比，单剂量阿奇霉素治疗并没有提升第 14 天无症状患者的比例（两组均为 50%，$P>0.99$）[38]。

推荐说明：目前尚缺乏证据支持抗菌药物用于 COVID-19 的治疗，除非有抗菌治疗指征，方可对确诊 COVID-19 患者使用抗菌药物。

问题 8：对于 COVID-19 门诊患者应如何实施退热治疗？

推荐意见 8：可进行物理降温，或（和）使用药物退热治疗。建议使用最低有效剂量，以尽可能减少常见不良反应。在妊娠情况下，使用对乙酰氨基酚的生殖毒性相较于非甾体抗炎药（nonsteroidal anti-inflammatory drugs，NSAID）更小。（证据级别为低质量；推荐强度为弱推荐）

证据概述：一项利用 1997 至 2011 年国家预防出生缺陷研究（NBDPS）数据比较 NSAID 加/不加阿片类药物和对乙酰氨基酚不加 NSAID 或阿片类药物与出生缺陷的研究，结果显示与对乙酰氨基酚相比，围孕期（妊娠前 1 个月至妊娠第 3 个月）暴露于 NSAID 的女性所生婴儿更易出现出生缺陷（校正 *OR* 范围为 1.2～1.6）[39]。

推荐说明：COVID-19 患者如果出现发热，可进行对症治疗，与成人退热的一般处理方式一致。基于 NBDPS 研究结果及 FDA 公告[39-40]，建议妊娠状态下首选对乙酰氨基酚，避免在妊娠期使用 NSAID，如必须使用该药，需使用最低有效剂量并缩短使用时长。

问题 9：门诊患者中医中药使用时机及人群？

推荐意见 9：中医治疗详见《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》推荐[4]。（证据级别为专家意见；推荐强度为 GPS）

推荐说明：

1. 一项中药热炎宁合剂治疗 2 830 例无症状和轻度感染者的前瞻、开放、对照研究按照 1∶1 的比例随机分组，结果发现中药干预后核酸转阴时间显著缩短[41]，并可加速病毒清除，促进无症状和轻度感染的疾病恢复。

2. 一项前瞻性、多中心、RCT 将确诊 COVID-19 患者随机分为常规治疗组和单独或联合应用连花清瘟胶囊组，284 例全分析集的结果显示，相对于常规治疗组，连花清瘟组的恢复率明显更高（91.5% 比 82.4%，$P=0.022$）；中位时间明显更短（7 d 比 10 d，$P<0.001$）；发热恢复时间（2 d 比 3 d）、疲劳（3 d 比 6 d）和咳嗽（7 d 比 10 d）也显著缩短（均 $P<0.001$）；胸部 CT 表现改善率（83.8% 比 64.1%，$P<0.001$）和临床治愈率（78.9% 比 66.2%，$P=0.017$）也较高；然而，两组在重症转化率或病毒检测结果方面差异均无统计学意义（均 $P>0.05$）；没有严重不良事件报告[42]。

3. 一项基于真实世界数据库的回顾性队列研究纳入了 2020 年 1 月至 5 月中国国家回顾性登记系统中连续住院的 8 939 例 COVID-19 患者，其中 28.7% 的患者接受了清肺排毒汤（以下简称 QPT）治疗；研究结果显示接受 QPT 的患者中，COVID-19 相关病死率为 1.2%（95%*CI* 0.8%～1.7%），未接受 QPT 患者为 4.8%（95%*CI* 4.3%～5.3%）；调整患者特征和伴随治疗后，使用 QPT 可以降低 50% 院内 COVID-19 相关死亡风险（*HR*=0.50，95%*CI* 0.37～0.66，$P<0.001$）；两组急性肝肾损伤差异无统计学意义[43]。

由于中医治疗 COVID-19 对疾病进展尚存争议，所以针对 COVID-19 患者，可参照《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》《关于在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作的通知》中推荐的中成药或中药协定方，进行居家治疗[4]。

五、总结

本指南基于现有的最佳证据，为门诊医师提供了关于评估和治疗的参考。部分推荐意见基于现有参考证据和专家经验，故有无证据或低质量证据产生弱推荐和 GPS 的情况，因此当高质量证据出现后，相关推荐意见可能会改变。本指南也会根据证据更新情况进行每年不少于 1 次的版本更新。

本指南提供了 9 个临床问题及 11 项主要推荐意见的概要，以及支持每项推荐意见的临床研究数据摘要（表 4）。

指南制订专家组（按姓氏汉语拼音为序）：白大鹏（天津市海河医院）、陈志海（首都医科大学附属北京地坛医院）、党双锁（西安交通大学第二附属医院）、李树臣（哈尔滨医科大学附属第二医院）、连建奇（空军军医大学唐都医院）、林炳亮（中山大学附属第三医院）、刘映霞（深圳市第三人民医院）、宓余强（天津市第二人民医院）、彭劼（南方医科大学南方医院）、孙剑（南方医科大学南方医院）、吴超（南京大学医学院附属鼓楼医院）、许洁（上海交通大学医学院附属第九人民医院）、杨永峰（东南大学医学院附属南京市第二医院）、余祖江（郑州大学第一附属医院）、曾玫（复旦大学附属儿科医院）、张浩军（甘肃省第二人民医院）、张继明（复旦大学附属华山医院）、张凯宇（吉林大学第一医院）、张文宏（复旦大学附属华山医院）

指南审阅专家组（按姓氏汉语拼音为序）：陈世耀（复旦大学附属中山医院）、方邦江（上海中医药大学附属龙华医院）、胡必杰（复旦大学附属中山医院）、李太生（中国医学科学院 北京协和医院）、唐小平（广州医科大学）、王福生（解放军总医院第五医学中心）、王贵强（北京大学第一医院）、余宏杰（复旦大学公共卫生学院）、俞云松（浙江大学医学院附属邵逸夫医院）；赵彩彦（河北医科大学第三医院）；赵敏（解放军总医院第五医学中心）；赵英仁（西安交通大学第一附属医院）

表 4　指南推荐意见汇总

序号	临床问题	推荐意见	证据级别/推荐强度
1	已确诊 COVID-19 成年患者应在门诊接受哪些初始评估	建议已确诊 COVID-19 成年患者在门诊接受如下初始评估，以确定是进一步就诊或转诊：① 疾病症状及严重程度；② 氧饱和度；③ 具有进展为重症的高危因素；④ 病程	专家意见/GPS
2	在实行分级诊疗的地区，各级诊疗机构如何分工合作救治	在具备分级诊疗条件的地区，推荐如下分级诊疗方案：① 各级医疗机构门、急诊医师评估分型；② 一级医疗机构可以提供轻型及部分中型患者的临床诊疗；③ 二级医院提供轻型、中型和部分重型病例救治；④ 三级医院负责重型和危重型病例救治	专家意见/GPS
3	哪些患者进行 COVID-19 抗病毒治疗	推荐轻型、中型和部分重型 COVID-19 患者抗病毒治疗	专家意见/GPS
4	如何选择 COVID-19 抗病毒治疗的药物	抗病毒治疗药物的选择，建议优先选用口服小分子药物。药物选择需根据患者的基础疾病、合并用药，以及对药物的耐受情况做出个体化的药物推荐，明确患者是否有相关药物的禁忌证	中等质量/强推荐
5.1	COVID-19 门诊患者糖皮质激素治疗的适应证	对无吸氧需求的轻型及中型 COVID-19 患者，不推荐全身使用糖皮质激素治疗。需要说明的是，如果上述患者疾病出现进展（包括新出现吸氧需求或需要更高级别的呼吸支持），推荐在评估全身使用糖皮质激素风险和获益后，酌情考虑短期使用糖皮质激素	中等质量/强推荐
5.2	COVID-19 门诊患者糖皮质激素治疗的适应证	由于有关吸入性糖皮质激素疗效的证据不一致，同意 IDSA 的意见，不推荐使用吸入性糖皮质激素治疗 COVID-19，除非开展相关临床试验	中等质量/强推荐
6.1	是否需要对 COVID-19 门诊患者使用抗凝/抗血小板治疗	对于未开始使用此类药物的患者，则不推荐在门诊开始抗凝或抗血小板药物治疗，除非有特定的治疗指征	中等质量/强推荐
6.2	是否需要对 COVID-19 门诊患者使用抗凝/抗血小板治疗	对于已使用抗凝药物或抗血小板药物治疗基础病的 COVID-19 门诊患者，推荐继续使用此类药物	专家意见/GPS
7	是否需要对 COVID-19 门诊患者使用抗菌药物治疗	COVID-19 门诊患者无需抗菌药物治疗，除非合并细菌感染	中等质量/强推荐
8	对于 COVID-19 门诊患者应如何实施退热治疗	可进行物理降温或（和）药物退热治疗。建议使用最低有效剂量，以尽可能减少常见不良反应。在妊娠情况下，使用对乙酰氨基酚的生殖毒性相较于非甾体抗炎药更小	低质量/弱推荐
9	门诊患者中医中药使用时机及人群	中医治疗详见《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》推荐	专家意见/GPS

注：COVID-19 为新型冠状病毒感染；IDSA 为美国感染性疾病委会；GPS 为良好实践声明

方法学专家组：应峻、金雪娟、张嵬、辛继宾、王曼、王寅（复旦大学）
秘书组：张昊澄、眭舒岚、王钰琛、孙峰、周晛（国家传染病医学中心）
利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies[J]. BMJ, 2008, 336(7653): 1106-1110. DOI: 10.1136/bmj.39500.677199.AE.

[2] Guyatt GH, Alonso-Coello P, Schünemann HJ, et al. Guideline panels should seldom make good practice statements: guidance from the GRADE Working Group[J]. J Clin Epidemiol, 2016, 80: 3-7. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2016.07.006.

[3] Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: clinical practice guidelines[J]. BMJ, 2016, 353: i2089. DOI: 10.1136/bmj.i2089.

[4] 国家卫生健康委办公厅，国家中医药局综合司. 新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）[EB/OL]. (2023-01-05)[2023-06-16]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/downFiles/460b0e7b19bd42f3bba00c1efb9b6811.pdf.

[5] Centers For Disease Control and Prevention. Underlying medical conditions associated with higher risk for severe COVID-19: information for healthcare professionals [EB/OL]. (2023-02-09)[2023-06-16]. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html.

[6] Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19[J]. N Engl J Med, 2022, 386(15): 1397-1408. DOI: 10.1056/NEJMoa2118542.

[7] PIFZER. Pfizer reports additional data on PAXLOVID™ supporting upcoming new drug application submission to U.S. FDA [EB/OL]. (2022-06-14)[2023-06-16]. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-reports-additional-data-paxlovidtm-supporting.

[8] Aggarwal NR, Molina KC, Beaty LE, et al. Real-world use of nirmatrelvir-ritonavir in outpatients with COVID-19 during the era of omicron variants including BA.4 and BA.5 in Colorado, USA: a retrospective cohort study[J]. Lancet Infect Dis, 2023, 23(6): 696-705. DOI: 10.1016/S1473-3099(23)00011-7.

[9] da Silva RM, Gebe Abreu Cabral P, de Souza SB, et al. Serial viral load analysis by DDPCR to evaluate FNC efficacy and safety in the treatment of mild cases of COVID-19[J]. Front Med (Lausanne), 2023, 10: 1143485. DOI: 10.3389/fmed.2023.1143485.

[10] Cabral P, de Souza S, Silva R D, et al. Serial viral load analysis by DDPCR to evaluate FNC efficacy and safety in the treatment of moderate cases of Covid-19 [J]. Front Med, 2023, 10(3): 1143485. DOI: 10.3389/fmed.2023.1143485.

[11] Butler CC, Hobbs F, Gbinigie OA, et al. Molnupiravir plus usual care versus usual care alone as early treatment for adults with COVID-19 at increased risk of adverse outcomes (PANORAMIC): an open-label, platform-adaptive randomised controlled trial[J]. Lancet, 2023, 401(10373): 281-293. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)02597-1.

[12] Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, et al. Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients[J]. N Engl J Med, 2022, 386(6): 509-520. DOI: 10.1056/NEJMoa2116044.

[13] Wong C, Au I, Lau K, et al. Real-world effectiveness of molnupiravir and nirmatrelvir plus ritonavir against mortality, hospitalisation, and in-hospital outcomes among community-dwelling, ambulatory patients with confirmed SARS-CoV-2 infection during the omicron wave in Hong Kong: an observational study[J]. Lancet, 2022, 400(10359): 1213-1222. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01586-0.

[14] Suzuki Y, Shibata Y, Minemura H, et al. Real-world clinical outcomes of treatment with molnupiravir for patients with mild-to-moderate coronavirus disease 2019 during the Omicron variant pandemic[J]. Clin Exp Med, 2022, 12: 1-9. DOI: 10.1007/s10238-022-00949-3.

[15] Cao Z, Gao W, Bao H, et al. VV116 versus nirmatrelvir-ritonavir for oral treatment of Covid-19[J]. N Engl J Med, 2023, 388(5): 406-417. DOI: 10.1056/NEJMoa2208822.

[16] 先声药业集团有限公司. 先诺欣! 首款国产 3CL 抗新冠创新药获批[EB/OL]. (2023-01-29)[2023-06-16]. http://www.simcere.com/news/detail.aspx?mtt=308.

[17] 众生药业. 广东众生药业股份有限公司关于来瑞特韦(RAY1216)片剂及原料药获得国家药品监督管理局批准上市的公告[EB/OL]. (2023-03-23)[2023-06-16]. http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-03-24/1216201477.PDF.

[18] 来瑞特韦片说明书[Z].

[19] Wang L, Berger NA, Davis PB, et al. COVID-19 rebound after Paxlovid and Molnupiravir during January-June 2022[J]. medRxiv, 2022, 6: 22276724. DOI: 10.1101/2022.06.21.22276724.

[20] Parums DV. Editorial: Rebound COVID-19 and cessation of antiviral treatment for SARS-CoV-2 with Paxlovid and Molnupiravir[J]. Med Sci Monit, 2022, 28: e938532. DOI: 10.12659/MSM.938532.

[21] Centers For Disease Control and Prevention. COVID-19 rebound after Paxlovid treatment[EB/OL]. (2022-05-24)[2023-06-16]. https://emergency.cdc.gov/han/2022/han00467.asp.

[22] 莫诺拉韦胶囊说明书[EB/OL]. [2023-03-01]. https://www.msdchina.com.cn/wp-content/uploads/2023/01/20221229_利卓瑞_药品说明书_首次获批.pdf.

[23] 中华人民共和国中央人民政府. 国家药监局附条件批准新冠病毒感染治疗药物先诺特韦片_利托那韦片组合包装、氢溴酸氘瑞米德韦片上市[EB/OL]. (2023-01-29)[2023-06-16]. http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/29/content_5739091.htm.

[24] 国家药品监督管理局. 国家药监局附条件批准新冠病毒感染治疗药物来瑞特韦片上市[EB/OL]. (2023-03-23)[2023-06-16]. https://www.nmpa.gov.cn/yaowen/ypjgyw/20230323145807117.html.

[25] 腾盛博药. 腾盛博药宣布的数据表明其长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗的联合疗法对活奥密克戎病毒 BA.4/5 及 BA.2.12.1 亚型变异株保持中和活性[EB/OL]. (2022-07-27)[2023-06-16]. https://cn.briibio.com/news-detail.php?id=1707#news.

[26] US Food and Drug Administration. FDA announces Evusheld is not currently authorized for emergency use in the U.S.[EB/OL]. (2023-01-26)[2023-06-16]. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-announces-evusheld-not-currently-authorized-emergency-use-us#update010623.

[27] National Institutes of Health. Anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies[EB/OL]. (2023-03-06)[2023-06-16]. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antivirals-including-antibody-products/anti-sars-cov-2-monoclonal-antibodies/.

[28] Takashita E, Yamayoshi S, Fukushi S, et al. Efficacy of antiviral agents against the Omicron subvariant BA.2.75[J]. N Engl J Med, 2022, 387(13): 1236-1238. DOI: 10.1056/NEJMc2209952.

[29] Imai M, Ito M, Kiso M, et al. Efficacy of antiviral agents against Omicron subvariants BQ.1.1 and XBB[J]. N Engl J Med, 2023, 388(1): 89-91. DOI: 10.1056/NEJMc2214302.

[30] Horby P, Lim WS, Emberson JR, et al. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19[J]. N Engl J Med, 2021, 384(8): 693-704. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436.

[31] Griesel M, Wagner C, Mikolajewska A, et al. Inhaled corticosteroids for the treatment of COVID-19[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2022, 3(3): CD015125. DOI: 10.1002/14651858.CD015125.

[32] Yu LM, Bafadhel M, Dorward J, et al. Inhaled budesonide for COVID-19 in people at high risk of complications in the community in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial[J]. Lancet, 2021, 398(10303): 843-855. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01744-X.

[33] Clemency BM, Varughese R, Gonzalez-Rojas Y, et al. Efficacy of inhaled ciclesonide for outpatient treatment of adolescents and adults with symptomatic COVID-19: a randomized clinical trial[J]. JAMA Intern Med, 2022, 182(1): 42-49. DOI: 10.1001/jamainternmed.2021.6759.

[34] Cools F, Virdone S, Sawhney J, et al. Thromboprophylactic low-molecular-weight heparin versus standard of care in unvaccinated, at-risk outpatients with COVID-19 (ETHIC): an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3b trial[J]. Lancet Haematol, 2022, 9(8): e594-e604. DOI: 10.1016/S2352-3026(22)00173-9.

[35] Barco S, Voci D, Held U, et al. Enoxaparin for primary thromboprophylaxis in symptomatic outpatients with COVID-19 (OVID): a randomised, open-label, parallel-group, multicentre, phase 3 trial[J]. Lancet Haematol, 2022, 9(8): e585-e593. DOI: 10.1016/S2352-3026(22)00175-2.

[36] National Institutes of Health. Therapeutic management of nonhospitalized adults with COVID-19[EB/OL]. (2022-12-28)[2023-06-16]. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management-of-adults/nonhospitalized-adults--therapeutic-management/.

[37] Azithromycin for community treatment of suspected COVID-19 in people at increased risk of an adverse clinical course in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial[J]. Lancet, 2021, 397(10279): 1063-1074. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00461-X.

[38] Oldenburg CE, Pinsky BA, Brogdon J, et al. Effect of oral

azithromycin vs placebo on COVID-19 symptoms in outpatients with SARS-CoV-2 infection: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2021, 326(6): 490-498. DOI: 10.1001/jama.2021.11517.

[39] Interrante JD, Ailes EC, Lind JN, et al. Risk comparison for prenatal use of analgesics and selected birth defects, National Birth Defects Prevention Study 1997-2011[J]. Ann Epidemiol, 2017, 27(10): 645-653.e2. DOI: 10.1016/j.annepidem.2017.09.003.

[40] US Food and Drug Administration. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): drug safety communication-avoid use of NSAIDs in pregnancy at 20 weeks or later[EB/OL]. (2020-10-15)[2023-06-16]. https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids-drug-safety-communication-avoid-use-nsaids-pregnancy-20#:~:text=FDA%20recommends%20that%20health%20care%20professionals%20should%20limit,the%20lowest%20effective%20dose%20and%20shortest%20duration%20possible.

[41] Xu X, Zhou S, Chen C, et al. Efficacy and safety of Reyanning mixture in patients infected with SARS-CoV-2 Omicron variant: a prospective, open-label, randomized controlled trial[J]. Phytomedicine, 2023, 108: 154514. DOI: 10.1016/j.phymed.2022.154514.

[42] Hu K, Guan WJ, Bi Y, et al. Efficacy and safety of Lianhuaqingwen capsules, a repurposed Chinese herb, in patients with coronavirus disease 2019: a multicenter, prospective, randomized controlled trial[J]. Phytomedicine, 2021, 85: 153242. DOI: 10.1016/j.phymed.2020.153242.

[43] Zhang L, Zheng X, Bai X, et al. Association between use of Qingfei Paidu Tang and mortality in hospitalized patients with COVID-19: a national retrospective registry study[J]. Phytomedicine, 2021, 85: 153531. DOI: 10.1016/j.phymed.2021.153531.

（收稿日期：2023-06-16）

（本文编辑：楚青）

·读者·作者·编者·

2023 年本刊一些常用词汇可直接用缩写

2023 年本刊对一些大家都比较熟悉的常用词汇将允许直接用缩写，即第 1 次出现时，可以不标注中文，它们是：

AFP（甲胎蛋白）
AIDS（艾滋病）
ALT（丙氨酸转氨酶）
APTT（活化部分凝血活酶时间）
AST（天冬氨酸转氨酶）
cccDNA（共价闭合环状脱氧核糖核酸）
CDC（疾病预防控制中心）
CHB（慢性乙型肝炎）
CHC（慢性丙型肝炎）
CK-MB（肌酸激酶同工酶）
CMV（巨细胞病毒）
CRP（C 反应蛋白）
CT（计算机断层成像）
CTL（细胞毒性 T 淋巴细胞）
DAB（二氨基联苯胺）
DBil（直接胆红素）
DC（树突状细胞）
dNTP（脱氧核苷三磷酸）
D-GalN（D-氨基半乳糖）
EDTA（乙二胺四乙酸）
ELISA（酶联免疫吸附测定）
ESR（红细胞沉降率）
FITC（异硫氰酸荧光素）
GAPDH（甘油醛-3-磷酸脱氢酶）
HAART（高效抗反转录病毒治疗）
HAV（甲型肝炎病毒）
HBcAg（乙型肝炎核心抗原）
HBeAg（乙型肝炎 e 抗原）
HBsAg（乙型肝炎表面抗原）
HBV（乙型肝炎病毒）
HCC（肝细胞癌）
HCV（丙型肝炎病毒）
HDV（丁型肝炎病毒）
HEV（戊型肝炎病毒）
HIV（人类免疫缺陷病毒）
HR（风险比）
HRP（辣根过氧化物酶）
H-E 染色（苏木精-伊红染色）
ICU（重症监护病房）
IL（白细胞介素）
INR（国际标准化比值）
IPTG（异丙基-β-D-硫代半乳糖苷）
miRNA（微 RNA）
MRI（磁共振成像）
MSM（男男同性性行为者）
NAs[核苷（酸）类似物]
OR（比值比）
PBMC（外周血单个核细胞）
PBS（磷酸盐缓冲液）
PCR（聚合酶链反应）
PET-CT（正电子发射计算机断层成像）
PPD（精制结核菌素试验）
PT（凝血酶原时间）
PTA（凝血酶原活动度）
PVDF（聚偏二氟乙烯）
RR（相对危险度）
SDS-PAGE（十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳）
TGF（转换生长因子）
Th（辅助性 T 淋巴细胞）
TLR（Toll 样受体）
TNF（肿瘤坏死因子）
Treg（调节性 T 淋巴细胞）
Tris-HCl（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐）
T-SPOT.TB（结核感染 T 淋巴细胞斑点试验）
WHO（世界卫生组织）
γ-GT（γ-谷氨酰转肽酶）
抗-HBc（乙型肝炎核心抗体）
抗-HBe（乙型肝炎 e 抗体）
抗-HBs（乙型肝炎表面抗体）
95%*CI*（95% 可信区间）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究